HOLISTICA DOC
ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

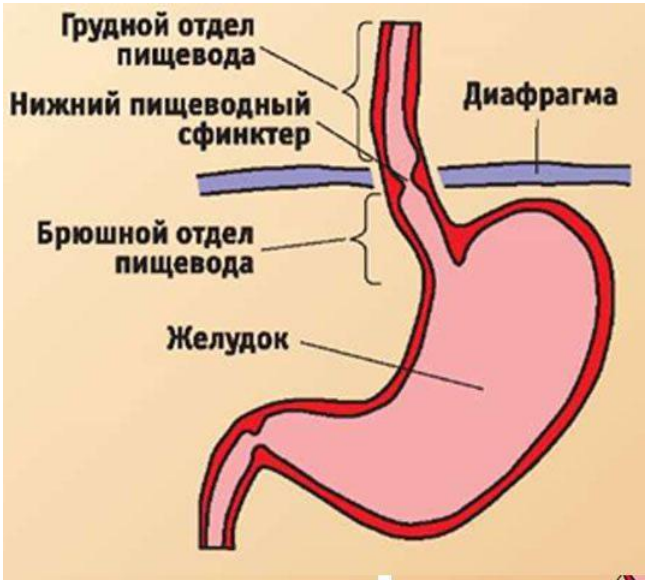
Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ

Конспект урока — Изжога, рефлюкс, ГЭРБ. Часть 1

1. Изжога и рефлюкс — что это и почему появляются

Пищевод — трубка, по которой пища из ротовой полости попадает в желудок. Между пищеводом и желудком находится **нижний пищеводный сфинктер (НПС)** — мышечный клапан, который в обычном состоянии сомкнут и размыкается только тогда, когда нужно пропустить в желудок еду или напиток.



Анатомия: пищевод, нижний пищеводный сфинктер, диафрагма, желудок

Изжога — это комплекс ощущений:

- **жжение в пищеводе** — по центру груди, выше желудка;
- кислый или горький **привкус во рту**;
- **отрыжка** — воздух поднимается из желудка наверх;
- ощущение **заброса кислоты или горечи в горло**;
- **боль за грудиной** в области пищевода.

Когда появляется: как правило **после еды**, после определённых продуктов и напитков, **при наклонах** и **в положении лёжа.**

Изжогу вызывает рефлюкс — попадание содержимого желудка обратно в пищевод.

2. Физиологический рефлюкс — это норма

Физиологический (нормальный) рефлюкс есть у всех здоровых людей. Нормой считается несколько десятков маленьких забросов в течение суток — у человека без повреждений пищевода и без диагнозов.

- **В норме вообще никак не ощущается** — изжоги и болей нет.
- Чаще возникает **после еды**, длится недолго — **3–5 минут.**
- Не вызывает **воспаления и повреждения слизистой.**
- **Быстро устраняется** естественными защитными механизмами организма.

Почему заброс вообще опасен: в желудке очень кислая среда — **pH 1–3**. Клетки желудка адаптированы к ней, и его защищает толстый слой слизи. В пищеводе всё иначе: там в норме **слабощелочная среда**, которая формируется за счёт слюны, а защита устроена слабее. *Поэтому регулярный и длительный контакт слизистой пищевода с содержимым желудка её повреждает.*

В норме пища движется сверху вниз благодаря:

- **перистальтике** — моторным сокращениям ЖКТ;
- **работе сфинктеров** — клапанов, которые мешают обратному движению;
- **разнице давления** между отделами ЖКТ.

Антирефлюксные механизмы — то, чем тело защищается от заброса:

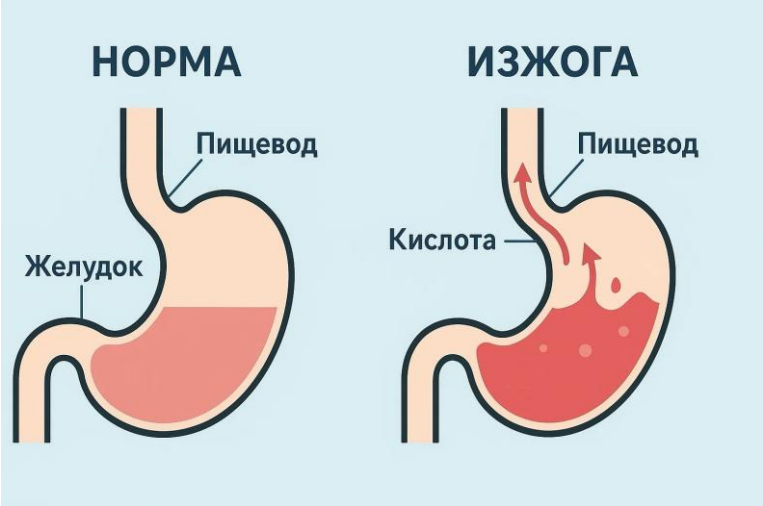
- **нижний пищеводный сфинктер** — клапан между пищеводом и желудком;
- **ножки диафрагмы** — мышечная структура, которая плотно охватывает пищевод в отверстии диафрагмы;
- **угол Гиса** — угол впадения пищевода в желудок;
- нормальная **перистальтика пищевода**;
- **очищение пищевода слюной** — слабощелочная слюна нейтрализует заброшенную кислоту;
- **защитный слой муцина** на слизистой пищевода.

Рефлюкс есть у всех, но изжога — не у всех. Изжога появляется тогда, когда антирефлюксные механизмы нарушаются.

3. Когда рефлюкс становится проблемой

Проблема возникает, если:

- изжога **становится частой;**
- эпизоды заброса **продолжаются долго;**
- нарушаются **антирефлюксные механизмы** — например, формируется грыжа пищеводного отверстия диафрагмы или неплотно смыкается НПС;
- **слизистая пищевода регулярно контактирует с агрессивным содержимым** — соляной кислотой, пепсином, желчными кислотами, содержимым двенадцатиперстной кишки.



Норма и изжога: заброс кислоты из желудка в пищевод

Когда нужно обследование: если изжога, отрыжка, боли и другие признаки рефлюкса возникают **2 и более раз в неделю** и **регулярно на протяжении 4–8 недель.**

Это может быть проявлением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Изжога — сигнал о возможном повреждении слизистой пищевода.

4. Что скрывается за изжогой: три состояния

За регулярной изжогой, которая держится больше 4 недель, могут стоять **три разных состояния.** Они отличаются по тяжести и *корректируются по-разному* — поэтому важно их различать.

1. Функциональная изжога

2. Гиперчувствительный пищевод

3. ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь



Слева направо: чрезмерный рефлюкс (ГЭРБ), гиперчувствительный пищевод, функциональная изжога

5. Функциональная изжога

Пищевод не повреждён, воспаления нет, слизистая цела — а жалобы есть.

Изжога и боли в пищеводе могут быть даже тогда, **когда рефлюкса нет.** Это расстройство, связанное с **нарушением восприятия боли** и обработки сигналов нервной системой: на слизистую не попадает ничего сверхагрессивного, но нервная система реагирует избыточно активно.

Часто сочетается с другими функциональными заболеваниями ЖКТ:

- синдром раздражённого кишечника (СРК);
- функциональная диспепсия — нарушение пищеварения в желудке;
- функциональный запор;

- а также **тревожность, хронический стресс, нарушения сна.**

Наблюдение из практики: у таких людей гиперчувствителен **не только пищевод.** *Они остро реагируют на стресс, плохо переносят перепады температуры, у них чувствительная слизистая рта и зубы, их раздражает яркий свет и громкие звуки.*

6. Гиперчувствительный пищевод

Пищевод не повреждён, воспаления нет, слизистая цела — а жалобы есть.

Рефлюкс есть, **но он физиологичный (нормальный).** При этом у человека активные жалобы — на изжогу, жжение, боли, *как будто рефлюкс сильный.*

Причина: избыточная чувствительность рецепторов пищевода, когда даже нормальный эпизод физиологического рефлюкса вызывает жалобы.

Основные механизмы избыточной чувствительности:

- нарушение **плотных межклеточных контактов** и повышение проницаемости слизистой пищевода;
- **снижение порога чувствительности рецепторов** + усиление восприятия боли центральной нервной системой.

Важно: повышенная проницаемость слизистой **предшествует формированию воспаления.** Если оставить гиперчувствительный пищевод без внимания — «обследование чистое, ну и пусть болит» — со временем воспаление может присоединиться. *Закрывать глаза на функциональную изжогу и гиперчувствительный пищевод не стоит.*

Функциональная изжога и гиперчувствительный пищевод чаще всего встречаются у людей с ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ типом пищеварения (расстройство доша Ветер / Вата).

7. ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Хроническое заболевание, при котором рефлюкс становится патологическим: содержимое желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки, регулярно и длительно забрасывается в пищевод, вызывает жалобы и повреждает слизистую, вызывая воспаление.

У части людей есть дополнительно **дуоденогастральный рефлюкс** — заброс содержимого двенадцатиперстной кишки (прежде всего желчи) в желудок. Если затем происходит гастроэзофагеальный рефлюкс, в пищевод попадает **смешанное содержимое** желудка и кишечника, которое может быть особенно агрессивным.



Заброс желчи: из двенадцатиперстной кишки в желудок и далее в пищевод

ГЭРБ — одно из самых распространённых хронических заболеваний ЖКТ. Симптомы есть у **10–20% взрослого населения планеты**, а риск значимо увеличивается **после 40 лет.**

8. Симптомы ГЭРБ

Изжога — ощущение жжения за грудиной: начинается в подложечной области и распространяется вверх, к шее или горлу.

Чаще возникает: через **30–90 минут после еды**, после переедания, при наклонах вперёд, в положении лёжа, ночью, после жирной пищи, алкоголя, кофе, шоколада и газированных напитков.

Сила изжоги не всегда отражает тяжесть заболевания.

Внимание! Тихий рефлюкс: ГЭРБ может протекать почти бессимптомно — при слабой изжоге процесс бывает активным. *Особенно характерно для людей с вялым типом пищеварения. Эрозии и пищевод Барретта (предонкологическое состояние) в таких случаях находят случайно, при обследовании по другому поводу.*

Другие пищеводные симптомы:

- **Отрыжка** — воздухом, кислым содержимым, горечью. Чаще после еды, переедания, газированных напитков.
- **Регургитация** — пассивный заброс желудочного содержимого в рот или глотку *без тошноты и рвоты*: кислый привкус, горечь во рту, ощущение, что пища или жидкость поднимаются обратно по пищеводу.
- **Боль за грудиной** — жгучая или давящая.
- **Ком в горле** или за грудиной.
- **Ощущение затруднённого прохождения пищи** по пищеводу.
- **Боль при глотании** — маркер выраженного воспаления слизистой или эрозий. *У части людей на этом фоне развивается страх еды.*
- **Икота** — связана с раздражением диафрагмы или диафрагмального нерва при рефлюксе.

Обязательно к врачу: любая боль за грудиной требует исключения заболеваний сердца, а затруднённое прохождение пищи — обязательного обследования, так как может быть признаком осложнений.

9. Внепищеводные симптомы (маски) ГЭРБ

Это жалобы, которые *не связаны напрямую с пищеводом*, но тоже относятся к ГЭРБ.

ЛОР-маска	• першение и боль в горле, ком в горле, осиплость голоса; • хроническое покашливание или кашель, неприятный запах изо рта; • **частые диагнозы:** хронический фарингит, ларингит, тонзиллит, синусит.

Лёгочная маска	• хронический и ночной кашель, приступы удушья, одышка, свистящее дыхание; • характерно **усиление после еды, ночью и в положении лёжа;** • **возможные диагнозы:** бронхиальная астма *(особенно если начинается в позднем возрасте)*, хронический бронхит.
Сердечная маска	• чувство давления в груди, боль или жжение за грудиной; • сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца; • *для рефлюксной боли характерно появление после еды, при наклонах и лёжа.*
Стоматологическая маска	• эрозия эмали, повышенная чувствительность зубов; • кариес, стоматиты.

Если ЛОР-заболевания, кашель или проблемы с зубами постоянно рецидивируют и плохо поддаются лечению — стоит исключить ГЭРБ. Любые боли в груди требуют исключения сердечно-сосудистых заболеваний.

10. Причины ГЭРБ

Четыре ключевых механизма. У большинства людей работает **не один, а сразу несколько.**

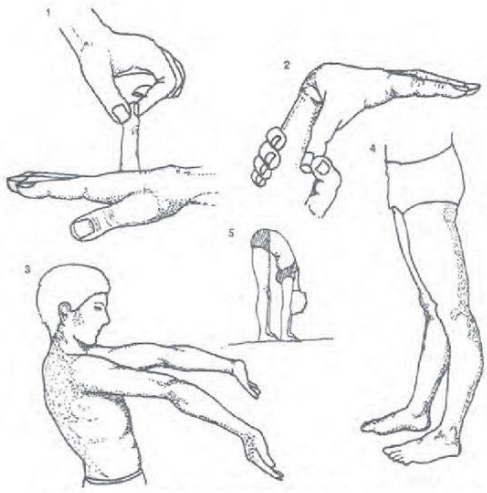
1. Снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера

НПС — главный клапан между пищеводом и желудком. В норме он открыт только во время глотания, а всё остальное время плотно закрыт. Если тонус снижается, клапан начинает *зиять*, и желудочное содержимое легче забрасывается в пищевод.

Причины снижения тонуса:

- **беременность** — вариант нормы, но проверить состояние пищевода всё равно нужно;

- **алкоголь и курение;**
- **кофеиносодержащие напитки** в больших количествах: крепкий чай, кофе, энергетики, кола;
- **снижение кислотности желудка** — высокая кислотность в норме помогает сфинктеру оставаться закрытым;
- **грыжа пищеводного отверстия диафрагмы** — мешает нормальному смыканию сфинктера;
- **дисплазия соединительной ткани (ДСТ).**



Признаки дисплазии соединительной ткани: гипермобильность суставов

Про ДСТ: это врождённая особенность, при которой соединительная ткань менее прочная и эластичная, хуже обновляется. *Проявляется с раннего детства: очень гибкие суставы, переразгибание пальцев и локтей, легко тянущаяся кожа. В восточной медицине — маркер конституции Вата.* Соединительная ткань входит в состав сфинктеров, диафрагмы и связок, поэтому при ДСТ все антирефлюксные структуры работают слабее. **В этой ситуации нужно целенаправленно поддерживать соединительную ткань питательными веществами — проблема касается не только пищевода.**

2. Значительное повышение внутрибрюшного давления



Мышцы брюшной стенки и диафрагма формируют внутрибрюшное давление

В норме внутрибрюшное давление выше, чем внутригрудное, однако обратному забросу содержимого желудка препятствует мощный антирефлюксный барьер. Но если давление в брюшной полости значительно возрастает, живот начинает поддавливать снизу вверх на желудок и диафрагму — сфинктер приоткрывается и **возникает рефлюкс.**

Причины:

- **беременность;**
- **тесная одежда;**
- **хроническое вздутие живота** — из-за СРК, СИБР, недостатка ферментов и других причин;
- **хронические запоры** и частое натуживание;
- **висцеральное ожирение** (жир в области живота);
- **переедание;**
- регулярная **работа в наклонном положении** и **поднятие тяжестей;**
- **хронический кашель.**

Важно: *часто бывает так, что вместе с висцеральным жиром на животе человек «прощается» и с изжогой — внутрибрюшное давление приходит в норму, и причина уходит.*

3. Нарушение моторики и секреторной функции ЖКТ

- **замедленное опорожнение желудка**, в том числе из-за пониженной кислотности;
- **нарушение координации** работы желудка, двенадцатиперстной кишки и желчевыводящей системы *(дискинезия желчевыводящих путей — самая частая история).*

В результате пища дольше задерживается в желудке, усиливаются процессы брожения и газообразования, повышается внутрижелудочное и внутрибрюшное давление, *возрастает вероятность заброса содержимого желудка в пищевод или содержимого 12-перстной кишки в желудок и затем в пищевод.*

4. Ослабление защитных факторов слизистой

Слизистая пищевода постоянно контактирует с пищей, желудочным соком и микроорганизмами, поэтому имеет собственную систему защиты: слой слизи, хорошее кровоснабжение, быстрое обновление клеток, достаточное слюноотделение и слаженную нервную регуляцию моторики и секреции.

Эффективность защиты снижается под влиянием факторов образа жизни:

- **еда на бегу и плохое жевание** — вырабатывается недостаточно слюны, которая омывает пищевод;
- **хронический недосып** и **хронический стресс** — дисрегуляция нервной системы;
- **дефицит белка**, необходимого для обновления тканей;
- **недостаточное потребление жиров**, участвующих в синтезе гормонов и нормальном желчеотделении;
- **нарушение пищеварения** и плохое усвоение питательных веществ.

В результате слизистая медленнее восстанавливается, снижается её устойчивость к действию кислоты, пепсина и желчных кислот, **а риск воспаления и повреждения пищевода возрастает.**

11. Факторы, усиливающие рефлюкс

Сами по себе они не всегда вызывают ГЭРБ, но способны значительно усиливать симптомы:

- быстрый приём пищи и плохое пережёвывание;
- газированные напитки;
- кофе — у чувствительных людей;
- горизонтальное положение сразу после еды;
- интенсивная физическая нагрузка после приёма пищи;
- хронический стресс.

Про тренировки: *упражнения в положении лёжа или в наклоне сразу после еды — плохая привычка. До активной нагрузки после еды должен пройти минимум час.*

12. Лекарства, которые могут усиливать ГЭРБ

Снижают тонус НПС	• нитроглицерин; • блокаторы кальциевых каналов (нифедипин, амлодипин, верапамил, дилтиазем); • антихолинергические и седативные препараты; • препараты прогестерона, в т.ч. некоторые КОК и препараты для гормональной терапии.
Замедляют опорожнение желудка	• **агонисты рецепторов GLP-1** (семаглутид, тирзепатид, лираглутид и др.); • некоторые антидепрессанты с антихолинергическим действием.
Раздражают слизистую пищевода	• доксициклин и тетрациклин; • препараты калия и железа.
Способствуют воспалению слизистой	• нестероидные противовоспалительные (ибупрофен, диклофенак, напроксен и др.); • ацетилсалициловая кислота.

13. Диагностика

Начинать нужно с **обращения к профильному специалисту — гастроэнтерологу.**

1. Оценка симптомов

Кроме жалоб по пищеводу оценивают и «маски». Полезно вести **дневник симптомов**: когда возникают жалобы, после каких продуктов, связь с физической нагрузкой, положение тела, ночные симптомы.

2. ФГДС (гастроскопия)

Основной метод оценки состояния слизистой пищевода. **Позволяет выявить:** воспаление и повреждение слизистой (эрозии, язвы), пищевод Барретта.

Гастроскопия не исключает ГЭРБ, так как у многих людей ГЭРБ есть без видимых изменений слизистой.

3. 24-часовая pH-импедансометрия

Наиболее точный метод подтверждения ГЭРБ и **дифференциальной диагностики** гиперчувствительного пищевода и функциональной изжоги. Позволяет определить количество рефлюксов, их длительность и кислотность (кислые, слабокислые, некислые), жидкие и газовые рефлюксы, а также **связь симптомов с эпизодами рефлюкса.**

4. Рентгенография с контрастом

Позволяет выявить грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, стриктуры, нарушения прохождения пищи. *ФГДС грыжу часто не показывает.*

5. Биопсия слизистой пищевода

Проводится при подозрении на пищевод Барретта, дисплазию или другие изменения слизистой.

Простой домашний тест — альгинатный

На фоне изжоги принять антацид (например, Гевискон). **Если это ГЭРБ, изжога купируется за 3–6 минут.** Если изжога не прошла — вероятно, это **не ГЭРБ**: может быть функциональная изжога, гиперчувствительный пищевод, кардиологические проблемы.

Тест не имеет стопроцентной диагностической ценности, но помогает понять, в правильном ли направлении вы думаете.

14. Осложнения ГЭРБ

Без лечения длительный контакт слизистой пищевода с кислотой, пепсином и **желчными кислотами** приводит к серьёзным последствиям. *Особенно*

неблагоприятен смешанный рефлюкс: желчные кислоты активно смывают защитный слой со стенок пищевода.

- **Эрозии и язвы пищевода** — могут сопровождаться болью, кровотечением и затруднением глотания.
- **Рубцевание и сужение пищевода** — основной симптом — постепенное затруднение прохождения пищи.
- **Пищевод Барретта** — нормальная слизистая нижнего отдела пищевода постепенно замещается атипичным эпителием. *Риск возрастает при длительно существующем рефлюксе, особенно с желчными кислотами. Нередко протекает бессимптомно и обнаруживается только при гастроскопии с биопсией.*
- **Аденокарцинома пищевода** — развивается не сразу, а через последовательную цепочку изменений, которая может занимать годы.

хронический рефлюкс → воспаление → пищевод Барретта → дисплазия → аденокарцинома

Именно поэтому длительно существующая ГЭРБ требует наблюдения и своевременного лечения. Пожалуйста, проходите обследование.

15. Как понять свой механизм развития изжоги

ГЭРБ, как правило, вторична по отношению к другим проблемам пищеварительной системы — она их следствие. Следствие высокого внутрибрюшного давления, неплотного смыкания сфинктера, низкой кислотности желудка и так далее.

У большинства людей изжога развивается **не по одной причине, а сразу по нескольким.** Поэтому важно определить, **какой механизм является ведущим именно у вас.**

Механизмы удобно разделить **по типам пищеварения.**

Вялый тип пищеварения



- изжога на **мучное, сладкое и жирное** — слизеобразующие продукты;
- **поздняя изжога** — через 30–60 минут после еды и позже;
- частая отрыжка, **без особого привкуса** во рту;
- ощущение, что **пища долго стоит в желудке**; тяжесть после еды;
- частое вздутие *(по типу дефицита ферментов желудка и поджелудочной, нарушения желчеоттока)*;
- **лишний вес в области живота.**

Что может быть: пища задерживается в желудке из-за низкой кислотности, слабой ферментной активности ЖКТ, замедленного опорожнения желудка. Внутрибрюшное давление усиливается из-за частого вздутия и абдоминального ожирения. Есть слабость нижнего пищеводного сфинктера.

Порядок работы: *если у вас вялый тип — сначала пересмотрите уроки по вздутию, определите свой тип вздутия и уберите его. Часто после этого изжогой заниматься отдельно уже не приходится.*

Воспалённый тип пищеварения



- изжога на **кислую и острую пищу**;
- **частая и продолжительная** изжога, выраженное жжение;
- может быть **боль в пищеводе** — говорит о повреждении слизистой;
- реакция на **кофе и алкоголь**;

- изжога **в положении лёжа и ночью.**

Что может быть: длительный контакт слизистой с кислым или смешанным рефлюктатом, воспаление слизистой пищевода, ГЭРБ, эрозивный эзофагит. *Это классический развитый вариант ГЭРБ.*

Чувствительный тип пищеварения



- изжога **непостоянная и быстро проходит**;
- реакция на **горький вкус** — кофе, чай, какао, горький шоколад;
- **усиливается на стрессе**;
- изжога при наклонах;
- жалобы **при нормальной гастроскопии**;
- есть СРК, спастические запоры.

Что может быть: гиперчувствительный пищевод; функциональная изжога; слабость обоих сфинктеров желудка, снижение защиты пищевода на фоне стресса.

Бывают и смешанные варианты: вялый с воспалённым, воспалённый с чувствительным, чувствительный с вялым.

16. Практический алгоритм оценки

Если:

✔ много газов

✔ вздутие

→ избыточное газообразование и повышение внутрикишечного давления.
Возможные причины: запоры, нарушение переваривания углеводов, недостаток пищеварительных ферментов, СИБР и др.

Если:

✔ тяжесть после еды

✔ жирная пища переносится плохо

✔ длительное чувство переполнения желудка

→ нарушение моторики желудка, недостаточное выделение желчи или пищеварительных ферментов.

Если:

✔ симптомы возникают после стресса

✔ изжога быстро возникает и быстро проходит

✔ гастроскопия без выраженных изменений

→ повышенная чувствительность пищевода из-за хр. стресса.

Если:

✔ хуже ночью

✔ хуже при наклонах

✔ хуже после переедания

→ повышение внутрибрюшного давления, снижение тонуса НПС / грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

17. Главный вывод урока

У большинства людей присутствует не один, а сразу несколько механизмов:

- слабый сфинктер + СИБР;
- нарушение моторики + стресс;
- запоры + желчный рефлюкс;
- ферментная недостаточность + гиперчувствительный пищевод.

Именно поэтому **универсального лечения ГЭРБ не существует.** Чтобы добиться стойкой ремиссии, важно определить **ведущий механизм**, а затем устранить факторы, которые поддерживают рефлюкс именно у вас.

18. Вопросы для самопроверки

Ответьте своими словами, не подглядывая в конспект. Если ответ не складывается — вернитесь к указанному разделу.

Норма и механизмы

1. Чем физиологический рефлюкс отличается от патологического? *(разделы 2–3)*

2. Почему заброс повреждает пищевод, а сам желудок от своего содержимого не страдает? *(раздел 2)*

3. Назовите шесть антирефлюксных механизмов. *(раздел 2)*

4. При какой частоте и длительности жалоб нужно идти на обследование? *(раздел 3)*

Состояния и симптомы

5. Три состояния за изжогой: что происходит со слизистой и с рефлюксом в каждом из них? *(разделы 4–7)*

6. Что такое тихий рефлюкс и для какого типа пищеварения он особенно характерен? *(раздел 8)*

7. Назовите четыре маски ГЭРБ и хотя бы по одному диагнозу для каждой. *(раздел 9)*

8. Какие два симптома требуют обязательного дополнительного обследования и почему? *(раздел 8)*

Причины и диагностика

9. Перечислите четыре механизма развития ГЭРБ. *(раздел 10)*

10. Почему **низкая** кислотность желудка способствует рефлюксу? *(раздел 10)*

11. Что такое дисплазия соединительной ткани и при чём здесь изжога? *(раздел 10)*

12. Почему одной ФГДС для исключения ГЭРБ недостаточно и какой метод считается самым точным? *(раздел 13)*

13. Как проводится альгинатный тест и о чём говорит отрицательный результат? *(раздел 13)*

14. Восстановите цепочку развития аденокарциномы пищевода. *(раздел 14)*

Практика

15. Почему при вялом типе пищеварения сначала работают со вздутием, а не с изжогой? *(раздел 15)*

16. Почему универсального лечения ГЭРБ не существует? *(раздел 17)*

19. Практическое задание

1. **Отметьте свои симптомы** — пищеводные и внепищеводные (разделы 8 и 9). Обратите внимание на «маски», которые вы раньше не связывали с ЖКТ.
2. **Определите свой тип пищеварения** по разделу 15. Если признаков из разных типов поровну — выпишите оба.
3. **Пройдите по алгоритму** раздела 16 и сформулируйте одной фразой: *«Мой ведущий механизм — …»*
4. **Проверьте свои лекарства** по списку из раздела 12. *Ничего не отменяйте самостоятельно — обсудите с врачом.*
5. **Если жалобы возникают 2+ раза в неделю дольше 4 недель** — запишитесь к гастроэнтерологу и возьмите с собой дневник симптомов.
6. **Ведите дневник симптомов две недели** — он даст врачу больше, чем любые ваши воспоминания на приёме.

Дневник симптомов

Заполняйте в течение двух недель. Отдельно отмечайте ночные эпизоды.

Дата и время	Что ел(а) / пил(а)	Симптом и сила 0–10	Положение тела, нагрузка

В следующем уроке — тактика коррекции: питание, образ жизни, нутрицевтики и другие средства, которые помогают убрать изжогу и рефлюкс.